

Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa



Ajuste a tela para leitura horizontal.



Baixe e imprima este
material em formato A4.



Apresentação

A dor é uma experiência subjetiva, pessoal e multidimensional que envolve componentes sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e socioculturais. Pode estar associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos, mas também pode se manifestar na ausência de causas físicas identificáveis (Desantana *et al.*, 2020).

Na Atenção Primária à Saúde (APS), compreender e avaliar adequadamente a dor é essencial para promover o cuidado integral e humanizado, orientar condutas clínicas, monitorar intervenções e garantir o direito ao alívio da dor como parte da atenção à saúde. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica (Brasil, 2024), a avaliação da dor deve ser sistemática e registrada como parte da prática clínica habitual na APS.

A avaliação da dor deve ir além da simples constatação de presença ou ausência. Isso requer um olhar atento para diferentes dimensões e para o modo como interfere na vida da pessoa (Silva; Ribeiro-Filho, 2011). Do ponto de vista clínico e psicométrico, distinguir entre avaliar e mensurar a dor igualmente é importante. Avaliar refere-se a compreender a dor no contexto do sujeito, incluindo os significados e impactos funcionais. Já mensurar implica quantificar características específicas da dor, como intensidade ou qualidade, com instrumentos padronizados

(Turk *et al.*, 2003). Vale destacar que a dor é considerada o quinto sinal vital, ao lado da temperatura, respiração, pulso e pressão arterial. Isso exige que sua avaliação seja rotineira, registrada nos prontuários e considerada nas decisões clínicas (Nascimento; Kreling, 2011). A ausência de instrumentos padronizados, ou a má utilização, pode resultar em subtratamento da dor e em iatrogenias. Por isso, utilizar escalas com embasamento científico, adaptadas culturalmente e adequadas ao perfil da pessoa atendida, é um critério de qualidade assistencial.

É necessário, ainda, considerar que muitos pacientes vivenciam dor crônica de difícil controle, com mecanismos subjacentes variados — nociceptivos, neuropáticos ou nociplásticos — e com apresentações clínicas nem sempre compatíveis com os achados físicos. A avaliação da dor deve, portanto, estar integrada à análise multidimensional do sofrimento e ao diálogo clínico. Mais do que números, deve gerar sentido e orientar o cuidado.



Apresentação

A avaliação da dor, portanto, é parte fundamental do processo clínico e deve ser realizada com instrumentos válidos, confiáveis e acessíveis. A mensuração, por sua vez, permite comparações ao longo do tempo, entre pacientes e entre diferentes intervenções, servindo como base para decisões terapêuticas. Uma única medida da dor raramente é suficiente. Sempre que possível, recomenda-se combinar diferentes abordagens para captar melhor a complexidade da experiência dolorosa, especialmente em condições crônicas (Silva; Ribeiro-Filho, 2011).

Esta cartilha apresenta instrumentos reconhecidos na prática clínica e com potencial para auxiliar profissionais da APS a avaliar diferentes aspectos da dor. São incluídas escalas unidimensionais, como a Escala Numérica, a Escala Visual Analógica, a Escala Verbal e a Escala de Faces, que se concentram principalmente na intensidade da dor percebida. Além disso, são apresentados instrumentos comportamentais, como a escala FLACC (Bussotti; Guinsburg; Pedreira, 2015) e a escala PAINAD (Valera *et al.*, 2014), voltados à avaliação da dor em pessoas com limitação na comunicação verbal. Por fim, são abordados instrumentos multidimensionais, como o Questionário McGill de Dor (Pimenta; Teixeira, 1996) e o Inventário Breve de Dor (Toledo, 2008), que permitem explorar as várias dimensões da experiência dolorosa, incluindo aspectos sensoriais, emocionais e funcionais.

Cada instrumento é contextualizado a partir do seu objetivo principal, os materiais necessários para a aplicação, o tipo de aplicação (se autorrelato ou se realizada pela observação do avaliador), o número de itens que o compõem, o tipo de escala utilizada, o intervalo de pontuação possível e a forma de obtenção do escore total. Também são indicados os pontos de corte ou classificações sugeridas, as propriedades psicométricas disponíveis e o tempo médio necessário à administração.



1. Instrumentos Unidimensionais

1.1 Escalas Unidimensionais de Intensidade Da Dor

As escalas unidimensionais de intensidade da dor são ferramentas amplamente utilizadas na prática clínica, em função da simplicidade e aplicabilidade rápida que apresentam (Turk *et al.*, 2003). Entre as mais conhecidas, estão a Escala Visual Numérica (EVN), a Escala Visual Analógica (EVA), a Escala de Avaliação Verbal (EAV) e a Escala de Faces (EF).

Embora sejam instrumentos valiosos para avaliar a intensidade da dor, essas escalas são limitadas em caráter unidimensional; ou seja, não capturam aspectos afetivos, cognitivos ou funcionais associados à dor crônica (Turk *et al.*, 2003). Além disso, o uso das escalas numérica e visual analógica pode ser desafiador em pacientes com baixo letramento, limitações cognitivas, idade avançada ou dificuldades de comunicação, situações comuns na Atenção Primária à Saúde. Alternativamente, é recomendado usar a Escala de Faces (Hicks *et al.*, 2001) ou a Escala Verbal (Turk *et al.*, 2003) com descritores ancorados em números para representar de maneira mais concreta a intensidade da dor. O Brasil conta, ainda, com uma versão de escala de faces para crianças, criada especialmente por Mauricio de Souza e testada na avaliação de crianças em tratamento de queimaduras (Claro, 1993).

Por serem unidimensionais, recomenda-se que essas escalas sejam utilizadas como parte de uma abordagem multidimensional, auxiliando na triagem inicial, no monitoramento da resposta ao tratamento e na comunicação entre profissional e paciente. A simplicidade as torna úteis na rotina das Unidades Básicas de Saúde, desde que interpretadas com cautela e complementadas por outras ferramentas mais abrangentes.



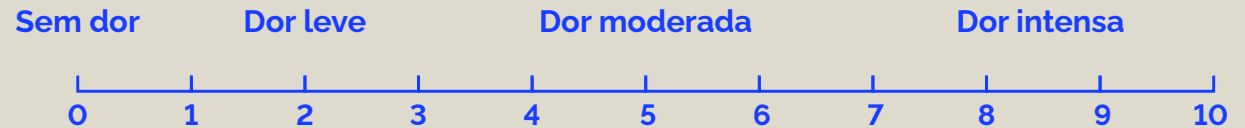
Qual é o objetivo dos instrumentos?

 Mensurar a intensidade da dor percebida pelo paciente, permitindo o acompanhamento clínico e a avaliação da resposta a intervenções.

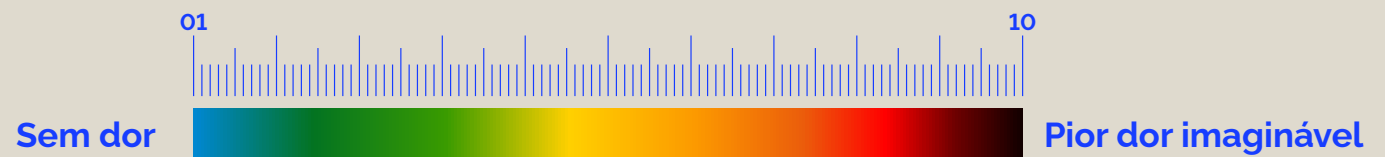


Quais são os materiais necessários para a aplicação?

Para a EVN, é necessária uma escala com **números de 0 a 10** impressa ou apresentada verbalmente.



Para a EVA, é necessária uma **linha reta de 10 cm** (em papel ou digital), com extremos identificados como "sem dor" e "pior dor imaginável" e uma **régua para medir a marcação feita pelo paciente**.





Quais são os materiais necessários para aplicação?

A **Escala de Avaliação Verbal** pode ter de **4 a 6 descritores verbais, ordenados por intensidade**, e a versão mais usada é a ancorada por número-palavra na sequência.

0

Sem dor

1

Dor fraca

2

Dor moderada

3

Dor severa

4

Dor insuportável

Para a **escala de faces**, é preciso ter o impresso adequado com **até 6 faces que expressem desde um semblante neutro (0. Sem dor) até um semblante de sofrimento (5. Dor severa)**.



0

Sem dor



1



2



3



4



5

Dor severa



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

As escalas são autorrelatadas ou dependem de avaliador?

São instrumentos autorrelatados, mas podem ser aplicados verbalmente quando necessário.

A pontuação total varia de quanto a quanto?

Na EVN, de 0 a 10. Na EVA, de 0 a 100 mm. Na Escala Verbal Ordinal, a pontuação é de 0 a 4, e na escala de faces é de 0 a 5.

Quantas questões ou itens possuem?

Todas essas escalas consistem em um único item que mede a intensidade de dor.

Como se obtém o escore total do questionário ou escala?

Na EVN, na Escala Verbal ou de Faces, o paciente escolhe verbalmente ou aponta o número correspondente à sua dor. Em crianças, pede-se para apontar ou indicar a face que mais se parece com o que está sentindo no momento. O valor correspondente à face indicada é registrado como escore da dor. Na EVA, mede-se com régua a distância (em mm) do ponto marcado pelo paciente até a extremidade “sem dor”.

Qual é a escala de avaliação dos itens?

A EVN utiliza uma escala numérica de 0 a 10. A EVA utiliza uma linha contínua de 10 cm, que é posteriormente medida em milímetros (0 a 100 mm). A escala verbal é composta por descritores verbais, frequentemente associados a um número, enquanto a escala de faces é pictórica e cada imagem é associada a um número.



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

Há um valor de corte ou classificação a partir da pontuação?

Geralmente, utiliza-se a seguinte classificação: 0 = sem dor, 1-3 = dor leve, 4-6 = dor moderada, 7-10 = dor intensa. Essa classificação pode ser adaptada para as escalas com menor número de itens e deve ser considerada apenas como orientativa e dependente da interpretação no contexto clínico.

Quais são as propriedades psicométricas disponíveis?

Apresentam validade de construto, boa confiabilidade e sensibilidade à mudança. São validadas no Brasil para uso com adultos e idosos, inclusive com dor crônica. Todas apresentam validade e confiabilidade adequadas para uso clínico e em pesquisas. A EVN é considerada a mais sensível e responsiva entre as unidimensionais (Turk *et al.*, 2003). A EVA tem boa precisão, mas pode gerar mais erros em idosos. A EAV é de fácil aplicação, com boa aceitação entre idosos (Andrade; Pereira; Sousa, 2006). A Escala de Faces mostra boa validade cruzada com outras escalas e é recomendada para pacientes com menor escolaridade ou dificuldades cognitivas leves (Hicks *et al.*, 2001). Além disso, apresenta boa validade de construto e critério, além de ser bem-aceita pelas crianças. Estudos demonstram boa correlação com escalas numéricas e visuais analógicas em crianças a partir de 3 anos.

Qual é o tempo médio para administrar as escalas?

Menos de 1 minuto em qualquer uma das escalas.



2. Instrumentos Comportamentais

2.1. Escala de avaliação de dor *Face, Legs, Activity, Cry, Consolability revised* – A Escala FLACC

A Escala FLACC (*Face, Legs, Activity, Cry, Consolability*) foi originalmente desenvolvida para avaliar a dor em crianças pequenas não verbalizantes, especialmente em contextos agudos, como o pós-operatório (Bussotti; Guinsburg; Pedreira, 2015). No entanto, a aplicação tem sido ampliada para outros grupos vulneráveis, como pacientes com déficits cognitivos, alterações neurológicas ou em estado de consciência reduzida, incluindo adultos com demência. Essa escala observa cinco categorias comportamentais – expressão facial, movimentação das pernas, atividade corporal, choro e consolabilidade – atribuindo pontuações que refletem a intensidade da dor.

Embora não tenha sido desenhada especificamente para o manejo da dor crônica, a FLACC pode ser útil como ferramenta complementar em contextos em que o paciente apresenta incapacidade de relatar a experiência de dor de forma confiável, como ocorre em alguns casos de dor crônica em pacientes com comunicação limitada (Bussotti; Guinsburg; Pedreira, 2015). Ademais, o uso clínico deve estar sempre integrado a uma abordagem multidimensional, que considere histórico clínico, contexto funcional e, quando possível, relatos de cuidadores e observações longitudinais.



Qual é o objetivo do instrumento?

A Escala FLACC é projetada para avaliar a intensidade da dor em crianças e pacientes que não são capazes de expressar verbalmente sua dor.



Quais os materiais necessários para aplicação?

Não há necessidade de materiais específicos além do próprio **formulário da Escala FLACC**, que inclui uma **tabela para anotar a pontuação** em cada categoria.

As escalas são autorrelatadas ou dependem de avaliador?

A escala depende de um avaliador externo que observa o paciente e preenche a escala, baseado em observações objetivas.

Quantas questões ou itens possuem?

A Escala FLACC tem 5 itens: *Face*, *Legs* (pernas), *Activity* (atividade), *Cry* (choro), e *Consolability* (consolabilidade).

Qual é a escala de avaliação dos itens?

Cada item é avaliado em uma escala de 0 a 2, em que 0 indica a ausência do comportamento relacionado à dor, e 2 indica uma forte manifestação do comportamento.



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

A pontuação total varia de quanto a quanto?

A pontuação total varia de 0 a 10, em que 0 significa nenhuma dor e 10 representa dor extrema.

Como se obtém o escore total do questionário ou escala?

O escore total é obtido pela soma das pontuações dos 5 itens, permitindo uma avaliação rápida e objetiva da dor do paciente.

Há um valor de corte ou classificação a partir da pontuação?

Geralmente, um escore maior ou igual a 4 sugere a necessidade de intervenções para o alívio da dor.

Quais são as propriedades psicométricas disponíveis?

A escala é conhecida por sua validade e confiabilidade em diversos contextos clínicos, especialmente em pediatria e para pacientes não verbais em cuidados intensivos (Bussotti; Guinsburg; Pedreira, 2015).

Qual é o tempo médio para administrar as escalas?

A aplicação da escala é rápida, geralmente levando menos de 5 minutos para completar a observação e o registro das pontuações.



2. Instrumentos Comportamentais

2.2. A Escala *Pain Assessment in Advanced Dementia* – A PAINAD

A escala PAINAD (*Pain Assessment in Advanced Dementia*) foi desenvolvida para avaliar dor em pessoas com demência avançada, que perderam a capacidade de se comunicar verbalmente de forma eficaz (Valera *et al.*, 2014).

Baseada na observação de cinco indicadores comportamentais — respiração independente da vocalização, vocalização negativa, expressão facial, linguagem corporal e consolabilidade — a PAINAD oferece uma abordagem padronizada para identificar sinais de sofrimento em pessoas com comprometimento cognitivo severo (Valera *et al.*, 2014).

Embora tenha sido originalmente validada para dor aguda, a escala tem sido amplamente utilizada em contextos de dor crônica, em instituições de longa permanência e na Atenção Primária à Saúde, especialmente quando há suspeita de dor persistente sem relato verbal claro. Além disso, a aplicação clínica requer familiaridade com os padrões usuais de comportamento do paciente e atenção a mudanças que possam refletir agravamento do quadro doloroso. A PAINAD não substitui o julgamento clínico, mas funciona como ferramenta complementar importante no cuidado centrado na pessoa, permitindo o reconhecimento da dor crônica em populações vulneráveis e contribuindo para decisões terapêuticas mais apropriadas (Valera *et al.*, 2014).



Qual é o objetivo do instrumento?

A escala PAINAD objetiva avaliar a presença e intensidade da dor em pessoas com demência avançada que não conseguem se comunicar verbalmente, por meio da observação de comportamentos indicativos de dor.



Quais são os materiais necessários para aplicação

São necessários apenas a própria escala impressa e um profissional de saúde treinado para realizar a observação dos comportamentos do paciente.

As escalas são autorrelatadas ou dependem de avaliador?

Depende de avaliador. A aplicação da escala é baseada exclusivamente na observação do comportamento do paciente.

Quantas questões ou itens possuem?

A escala é composta por 5 itens: respiração independente da fala, vocalização negativa, expressão facial, linguagem corporal e consolabilidade.

Qual é a escala de avaliação dos itens?

Cada item é pontuado de 0 a 2, de acordo com a intensidade dos comportamentos observados.



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

A pontuação total varia de quanto a quanto?

A pontuação total varia de 0 a 10, sendo 0 indicativo de ausência de dor e 10 indicativo de dor intensa.

Como se obtém o escore total do questionário ou escala?

O escore total é obtido pela soma das pontuações dos 5 itens, permitindo uma avaliação rápida e objetiva da dor do paciente.

Há um valor de corte ou classificação a partir da pontuação?

Não há um ponto de corte fixo, mas geralmente considera-se que escores entre 0 e 1 indicam ausência de dor, 2 a 3 indicam dor leve, e 4 ou mais indicam dor moderada à intensa, sugerindo necessidade de intervenção.

Quais são as propriedades psicométricas disponíveis?

A escala apresenta boa confiabilidade interavaliadores e validade de construto, sendo apropriada para uso clínico em idosos com demência em estágios avançados, especialmente em contextos como instituições de longa permanência e cuidados paliativos (Valera *et al.*, 2014).

Qual é o tempo médio para administrar as escalas?

O tempo médio para a administração é de 3 a 5 minutos, considerando o período de observação necessário.



3. Instrumentos Multidimensionais e Mistos

3.1. O Questionário McGill de Dor

O Questionário McGill de Dor é um dos instrumentos mais amplamente utilizados na avaliação da dor crônica, desenvolvido por Ronald Melzack em 1975, no contexto da Universidade McGill, no Canadá. Foi concebido com base na teoria de que a dor é uma experiência multidimensional, composta por aspectos sensoriais, emocionais, cognitivos e comportamentais.

Ao incorporar descritores verbais organizados em diferentes domínios, o MPQ (sigla de Questionário McGill de Dor em inglês) permite uma caracterização rica da experiência dolorosa além da simples intensidade (Pimenta; Teixeira, 1996). É particularmente útil em contextos clínicos e de pesquisa, permitindo comparar padrões de dor entre indivíduos e acompanhar a resposta ao tratamento. Instrumento multidimensional, o Questionário McGill permite caracterizar diferentes aspectos da experiência dolorosa por meio de descritores verbais agrupados em domínios sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, cognitivo-avaliativo e miscelânea (Pimenta; Teixeira, 1996).



Qual é o objetivo do instrumento?

O Questionário McGill de Dor tem como objetivo avaliar a dor de forma qualitativa e multidimensional, abrangendo aspectos sensoriais, afetivos, cognitivos e temporais. É utilizado para auxiliar no diagnóstico, na escolha das estratégias terapêuticas e no monitoramento da evolução clínica da dor.



Quais são os materiais necessários para a aplicação?

São necessários o formulário do questionário contendo os descritores verbais de dor, organizados em subgrupos, um diagrama corporal para localização da dor, bem como um espaço para registrar características como intensidade, duração e intervenções analgésicas utilizadas.

As escalas são autorrelatadas ou dependem de avaliador?

O MPQ é um instrumento autorrelatado, podendo ser preenchido diretamente pelo paciente. Em casos de baixa escolaridade ou limitações cognitivas, pode ser aplicado com auxílio de um profissional de saúde.

Quantas questões ou itens possuem?

O questionário possui 78 descritores de dor organizados em 20 subgrupos, além de itens relacionados à localização, intensidade, duração e periodicidade da dor.

Qual é a escala de avaliação dos itens?

Cada subgrupo de descritores possui palavras ordenadas por intensidade, com valores de 0 a 5. O paciente seleciona um único descritor por subgrupo.



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

A pontuação total varia de quanto a quanto?

A pontuação total, denominada Índice de Avaliação da Dor (*Pain Rating Index*), pode variar de 0 a 78, dependendo dos valores associados aos descritores escolhidos.

Como se obtém o escore total do questionário ou escala?

O escore total é obtido pela soma dos valores atribuídos aos descritores selecionados em cada subgrupo. É possível, ainda, calcular escores parciais correspondentes aos domínios sensorial, afetivo, cognitivo e miscelânea.

Há um valor de corte ou classificação a partir da pontuação?

Não há um valor de corte definido. A interpretação do escore é clínica e visa acompanhar a evolução da dor e sua resposta ao tratamento.

Quais são as propriedades psicométricas disponíveis?

O instrumento apresenta validade de conteúdo e construto, alta confiabilidade (com bons coeficientes de consistência interna) e sensibilidade para diferenciar tipos e intensidades de dor, além de estar adaptado ao uso na população brasileira (Pimenta; Teixeira, 1996).

Qual é o tempo médio para administrar as escalas?

O tempo médio para administração varia de 3 a 4 minutos, podendo ser maior em pacientes com dificuldades de leitura ou compreensão.



3. Instrumentos Multidimensionais e Mistos

3.2. O Inventário Breve de Dor (*Brief Pain Inventory* – BPI)

O Inventário Breve de Dor é um instrumento desenvolvido inicialmente para avaliar dor em pacientes oncológicos, mas, atualmente, é amplamente utilizado em diversas condições clínicas, incluindo dor crônica não oncológica.

O material foi traduzido e validado para o português e tem sido utilizado no Brasil para mensurar tanto a intensidade da dor quanto o impacto que exerce na funcionalidade diária do paciente, de forma breve, confiável e multidimensional (Toledo, 2008).



Qual é o objetivo do instrumento?



Avaliar a intensidade e o impacto da dor na vida diária do paciente.



Quais são os materiais necessários para aplicação?

É necessária a versão impressa ou digital do questionário, bem como caneta para preenchimento do material (ou dispositivo eletrônico).

As escalas são autorrelatadas ou dependem de avaliador?

O BPI é autorrelatado.

Quantas questões ou itens possuem?

O BPI contém 15 itens (que podem variar conforme a versão utilizada, se curta ou longa), incluindo escalas numéricas e perguntas abertas.

Qual é a escala de avaliação dos itens?

Escala numérica de 0 a 10, em que 0 significa "sem dor" ou "sem interferência", e 10 significa "pior dor imaginável" ou "interferência total".



Escalas de Avaliação da Dor com Ênfase na Dimensão Sensório-Discriminativa

A pontuação total varia de quanto a quanto?

Cada item é pontuado individualmente de 0 a 10; não há uma soma geral padronizada.

Como se obtém o escore total do questionário ou escala?

Calcula-se a média dos escores de intensidade da dor (4 itens) e, separadamente, a média dos escores de interferência (7 itens), possibilitando uma visão integrada da dor e seu impacto.

Há um valor de corte ou classificação a partir da pontuação?

Não há um ponto de corte universalmente padronizado, mas valores mais altos indicam dor e impactos funcionais mais expressivos.

Quais são as propriedades psicométricas disponíveis?

Apresenta boas evidências de validade de construto, confiabilidade (alfa de Cronbach $> 0,80$) e sensibilidade à mudança clínica (Toledo, 2008).

Qual é o tempo médio para administrar as escalas?

De 5 a 10 minutos.



Conclusão

A avaliação da dor é
uma etapa essencial para
o cuidado qualificado e
centrado na pessoa

(Turk *et al.*, 2023).



Conclusão

Nesta cartilha, foram apresentados **instrumentos recomendados para uso na Atenção Primária à Saúde, com ênfase na dimensão sensório-discriminativa da dor**. Escalas unidimensionais, comportamentais e multidimensionais foram descritas de forma prática, considerando suas indicações, modos de aplicação e propriedades psicométricas.

É importante lembrar que nenhum instrumento isoladamente dá conta da complexidade da experiência dolorosa (Silva; Ribeiro-Filho, 2011). Por isso, recomenda-se que a escolha da escala considere o perfil clínico e comunicacional da pessoa atendida, além do contexto de uso. O registro sistemático da dor no prontuário, com instrumentos validados e adequados à realidade do SUS, fortalece a qualidade da atenção e contribui para a redução de falhas no manejo da dor (Brasil, 2024).

Espera-se que esta cartilha contribua para ampliar o repertório clínico dos profissionais da APS, apoiando o acolhimento, a escuta qualificada e o cuidado em situações não somente de dor crônica, mas também agudas.



Referências Bibliográficas

- ANDRADE, F. A. de; PEREIRA, L. V.; SOUSA, F. A. E. F. Mensuração da dor no idoso: uma revisão. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 14, n. 2, p. 271–276, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000200018>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf>. Acesso em: 10 maio 2025.
- BUSSOTTI, E. A.; GUINSBURG, R.; PEDREIRA, M. L. G. Adaptação cultural para o português do Brasil da escala de avaliação de dor Face, Legs, Activity, Cry, Consolability revised (FLACCr). **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 23, n. 4, p. 651–659, jul./ago. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.0001.2600>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- CLARO, M. T. **Escala de faces para avaliação da dor em crianças: etapa preliminar**. 1993. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Psiquiátrica) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1993. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.22.1993.tde-23052023-094130>. Acesso em: 13 abr. 2025.
- DESANTANA, J. M. *et al.* Revised definition of pain after four decades. **Brazilian Journal of Pain – BrJP**, v. 3, n. 3, p. 197–198, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200191>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- NASCIMENTO, L. A. do; KRELING, M. C. G. D. Avaliação da dor como quinto sinal vital: opinião de profissionais de enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 50–54, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002011000100007>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- HICKS, C. L. *et al.* The Faces Pain Scale-Revised: toward a common metric in pediatric pain measurement. **Pain**, v. 93, n. 2, p. 173–183, 2001. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(01\)00314-1](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00314-1). Acesso em: 1 dez. 2025.
- PIMENTA, C. A. de M.; TEIXEIRA, M. J. Questionário de Dor McGill: proposta de adaptação para a língua portuguesa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 30, n. 3, p. 473–483, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-62341996000300009>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- SILVA, J. A. da; RIBEIRO-FILHO, N. P. A dor como um problema psicofísico. **Revista Dor**, v. 12, n. 2, p. 138–151, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-00132011000200011>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- TOLEDO, F. O. **Adaptação cultural do inventário breve da dor para a língua portuguesa no Brasil e teste de suas propriedades psicométricas**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. Acesso em: 13 abr. 2025.
- TURK, D. C. *et al.* Core outcome domains for chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. **Pain**, v. 106, n. 3, p. 337–345, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pain.2003.08.001>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- VALERA, G. G. *et al.* Cultural adaptation of the scale Pain Assessment in Advanced Dementia – PAINAD to Brazil. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, n. 3, p. 462–468, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000300011>. Acesso em: 13 abr. 2025.



Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde - DEPPROS
Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - NTG PNPIC.

Angela Fernandes Leal da Silva – Diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde – DEPPROS.

Paulo Roberto Sousa Rocha – Coordenação Geral e Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Daniel Miele Amado – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Nathalia Oliveira da Silva – Assessora Técnica no Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria
Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria
Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral
Julieta Carriconde Fripp – Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta
Simone da Fonseca Sanghi – Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.



UFPEL



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Vitor Gouveia Cau

Diagramação e Design Gráfico

Danielle Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Anamaria Siriani de Oliveira